令和8年度
院内災害訓練
台本

令和9年3月6日（土）午前

済生会和歌山病院　災害医療委員会

更新 令和8年11月4日

委員用サイト
saigai-kunren.web.app

目次

訓練想定 3

全体の流れ（あらすじ） 4

指揮命令系統（組織図） 6

タイムライン（全部署） 7

部署別台本

災害対策本部 13

現地統括本部 16

新設部門・外来 19

腎センター 22

手術室 24

病棟 25

薬剤部 27

検査科 28

放射線科 30

栄養科 31

リハ科 33

ME 34

経理（設備） 35

地域連携（広報） 37

医局 39

巻末

全体配役表 40

名簿 46

訓練想定

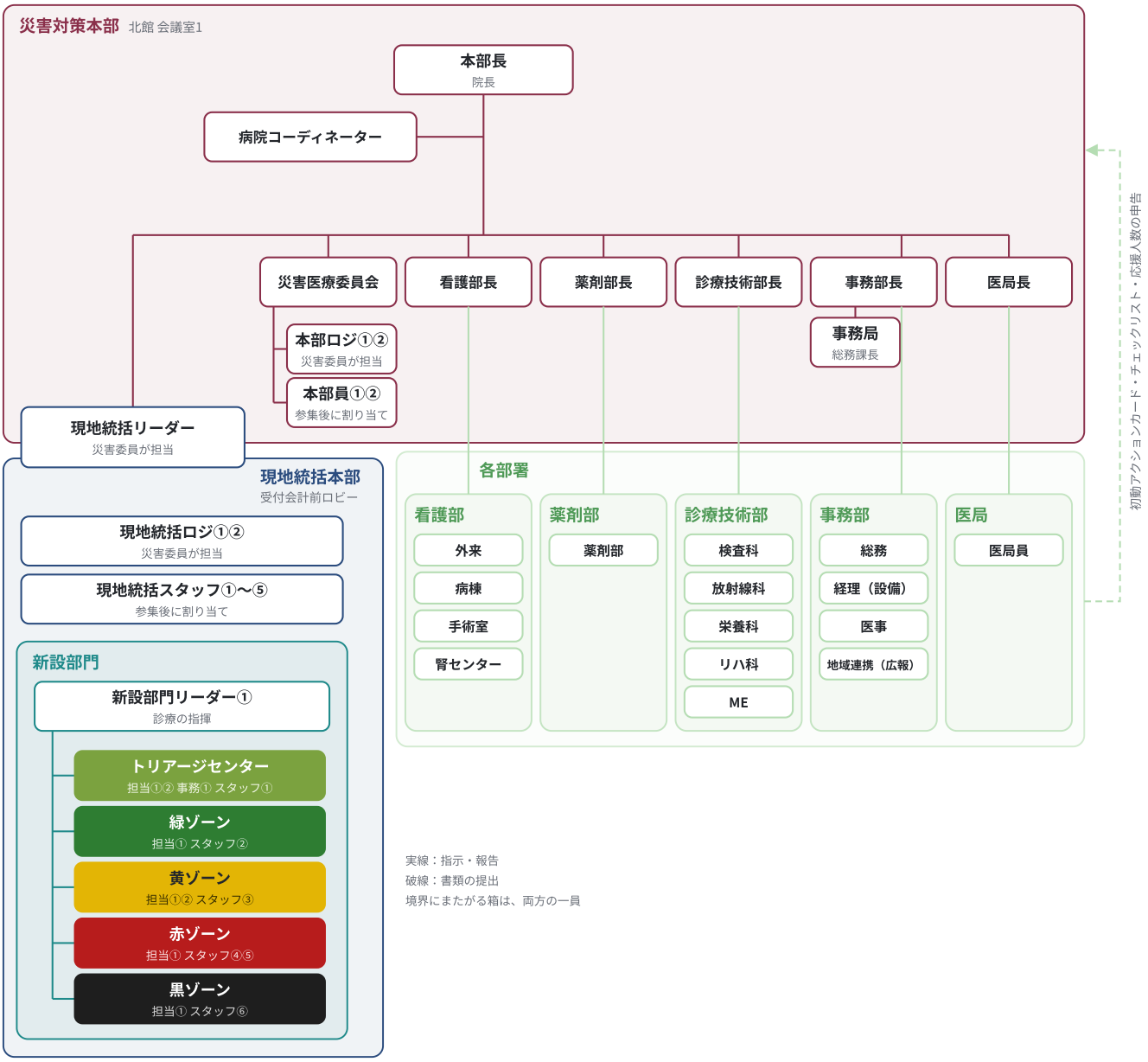
日時	令和9年3月6日（土）午前。外来と予定手術はありません。
発災	7:30。和歌山市で震度6弱。（レベル3を想定）
院内の状況	停電・断水。復旧の見込みなし。自家発電で供給します。
運転時間の目安	フル稼働のとき、地下2階 約12.5時間、本館5階 約23時間、北館 約12時間。節電で延びます。
燃料・給水	燃料・給水の依頼先は、自治体・酒直。依頼は、EMISにも入力します。供給は明日の見込みです。
電子カルテ	使えません。紙で運用します。
通信	PHS、トランシーバーが使えます。北館2階の衛星回線、防災センターのワイドスターが使えます。
場所	災害対策本部：北館会議室1。現地統括本部：本館1階 受付会計前ロビー。トリアージセンター：総合案内前ロビー。赤・黄ゾーン：外来の診察室前。一般参加者の集合・待機場所：外来の診察室前。看護学生の集合・待機場所：職員食堂。
時間	7:30〜8:00は、まだ訓練は始まっていません。この間の対応は、当直者や管理当直が行ったものとします。
初動アクションカード	各部署に貼ってあります。病棟を含む各部署の委員が、8:00の集合のときに本部へ持ってきます。
余震	9:15。震度5弱。院内放送で伝えます。各部署は、安全を確認し、被害の有無を本部へ報告します。
傷病者の来院	9:00、9:30、10:00の3回。
本部会議	10:30の1回。参加者は、本部長、本部ロジ、現地統括リーダー、新設部門リーダーです。
トイレ	節水のため、トイレは使用禁止とし、すみやかに仮設トイレを設置する。
参加者	看護学生 約20名（傷病者役 約15名、外部役ほか 約5名）。
対象外	発熱対応エリアは設置しません。

全体の流れ（あらすじ）

時刻	部署	主な動き
7:30	全部署	発災。安全確認と被害確認をして、管理当直へ報告
	全職員	安否確認メールが配信される
8:00	災害医療委員	訓練を開始。仮本部を北館会議室1に設置
	災害医療委員	院内放送で、「これから、災害訓練を始めます。訓練ですので、患者さんは、ご心配ありません」と伝える
	災害医療委員	現地統括本部を設営。安否確認メールの返信を集計
	全部署	各部署の委員が、集合のときに、初動アクションカードを本部へ持ってくる
8:30	本部	本部員が到着。院長が本部長を引き継ぐ
	一般参加者	外来の診察室前に集合する。受付会計前ロビーの現地統括本部で、登院登録（記名）をする
	看護学生	職員食堂に集合し、待機
8:35	本部	災害対策本部の設置を宣言。レベル3を宣言
	新設部門	リーダーを任命。持ち場に就く
8:45	本部	登院人数を集計。追加の応援を割り振る
	全部署	チェックリスト（被害状況報告書）を提出
8:50	本部	被災状況を確認。EMISへ第一報（燃料・給水の依頼も入力）
9:00	新設部門	トリアージを開始。傷病者の第1波
	本部	節水のためトイレを使用禁止とし、すみやかに仮設トイレを設置する
	● 現地統括本部	院外傷病者が来院し始める。現地統括ロジが、傷病者一覧（通し番号、ゾーン、帰宅・入院・搬送）を作り、各ゾーンの報告で更新する。入院が必要な傷病者は、病床を調整
	● 現地統括本部	現地統括リーダーの指示で、現地統括スタッフが、仮設トイレ（テント3つ）を設置
9:15	本部	余震（震度5弱）。院内放送で伝える
	全部署	放送を聞いて、安全確認。被害の有無を、本部へ報告。新設部門は、現地統括本部へ報告
9:30	新設部門	傷病者の第2波。赤ゾーンの人手不足
	● 現地統括本部	現地統括スタッフ④⑤が、赤ゾーンを応援
	本部	赤ゾーンの人手不足を受け、人員を再配置
9:45	外部役	自治体（県）から、ワイドスター・衛星回線に入電。「院内の被害状況と、いま受け入れられる傷病者数を教えてください」

10:00	新設部門	傷病者の第3波（緑・黄が中心）
10:15	外部役	保健所を通じて、和歌山県立医大から、入院患者3名の転院搬送の要請（①人工呼吸器の患者 ②維持透析が必要な患者 ③酸素吸入が必要な患者）
	● 本部・病棟	家族の安否の問い合わせ（病棟）、報道機関の取材（本部）、赤ゾーンの輸液・酸素ボンベの不足への対応
10:30	外部役	自衛隊から、燃料・給水の供給は明日の見込みと連絡。接続口の口径や場所などを問い合わせる
	本部	本部会議。定時報告。EMISを更新
	● 現地統括本部	現地統括スタッフ①②が、非常食の準備と配膳を応援
11:00	本部	訓練の終了を宣言。院内放送で伝える
11:00〜11:45	全員	振り返り

指揮命令系統（組織図）



実線：指示・報告
破線：書類の提出
境界にまたがる箱は、両方の一員

タイムライン（全部署）

行を押すと、その部署の台本の場面へ移動します。

時刻	部署	主な動き	場所
7:30	災害対策本部	**発災**：各部署の当直者から、被害の報告を受ける	院内
	新設部門・外来	**発災**：部署LINEで、スタッフの安否確認と参集を呼びかける	救急室
	腎センター	**発災**：安否を入力する。出勤できる人は出勤する	自宅
	手術室	**発災**：グループLINEで、スタッフの安否と出勤の可否を確認する	手術室
	病棟	**発災**：患者、設備、ナースコール、薬剤の安全確認をして、問題なしと報告する	全病棟
	薬剤部	**発災**：初動アクションカードで状況を確認し、管理当直へ報告する	薬剤部
	検査科	**発災**：連絡網で所属長へ連絡する	検査科
	放射線科	**発災**：安全確認と被害確認をして、管理当直へ報告する	放射線科
	栄養科	**発災**：安全を確保し、火を止める。被害を確認して、管理当直へ報告する	厨房
	リハ科	**発災**：安全を確保し、グループLINEで安否を確認する。登院できるかを確認する	自宅
	医局	**発災**：初動アクションカードで状況を確認し、管理当直へ報告する	医局・当直室
8:00	災害対策本部	**仮本部の設置**：仮本部を設置する	北館 会議室1
	災害対策本部	**初動アクションカードの受け取り**：集合のときに、担当する部署の初動アクションカードを、本部へ持ってくる	北館 会議室1
	現地統括本部	**設営**：現地統括本部を設営する。安否確認メールの返信の集計を、本部ロジ②と確認する	本館1階 受付会計前ロビー
	腎センター	**開始**：8:30の透析開始の可否を判断し、本部へ報告する	透析室
	腎センター	**初動アクションカード**：記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく	本部
	病棟	**初動アクションカード**：記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく	各病棟
	薬剤部	**初動アクションカード**：記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく	薬剤部
	検査科	**初動アクションカード**：記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく	検査科

	放射線科	**初動アクションカード**：記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく	放射線科
	栄養科	**初動アクションカード**：記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく	本部
	地域連携（広報）	**準備**：登院者管理表を準備する	現地統括本部
	医局	**初動アクションカード**：記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく	医局・当直室
8:30	災害対策本部	**本部員の到着**：到着し、仮の本部長から本部長を引き継ぐ	北館 会議室1
	現地統括本部	**登院**：登院登録をして、現地統括本部に着く。新設部門リーダーが着いたことを確認する	本館1階 受付会計前ロビー
	現地統括本部	**現地統括スタッフの登院**：登院登録をして、現地統括本部で待機する	本館1階 受付会計前ロビー
	新設部門・外来	**登院**：現地統括本部へ行き、現地統括リーダーの指示を受ける	現地統括本部
	手術室	**登院**：チェックリストに沿って、手術室内を確認する	手術室
	薬剤部	**登院**：部内の連絡網で安否を確認し、本部へ報告する	薬剤部
	放射線科	**登院**：登院登録をする	現地統括本部
	栄養科	**登院**：厨房の状況と調理の可否を、本部へ報告する	厨房
	リハ科	**登院**：リハビリ室の被害を確認する	リハビリ室
	ME	**登院**：登院登録をする	現地統括本部
	経理（設備）	**登院**：登院登録をする	現地統括本部
	地域連携（広報）	**登院**：参集者に、登院者管理表へ記名してもらう	現地統括本部
	医局	**登院**：登院登録をする	現地統括本部
8:35	災害対策本部	**本部の設置**：災害対策本部の設置を宣言する。レベル3を宣言する	北館 会議室1
	現地統括本部	**新設部門の配置**：新設部門リーダーから、配置が済んだか、報告を受ける。電子カルテは使えないため、紙カルテで運用すると伝える	本館1階 受付会計前ロビー
	新設部門・外来	**開始準備**：事前に決めた持ち場に就く	本館1階 総合案内前ロビー
	腎センター	**被害確認**：機器の作動と破損、透析資材、発電機、貯水量を確認する	透析室
	手術室	**被害の報告**：麻酔器は使える。電気メスなどは、電源があれば使える。手洗い場は使えない。記録は紙で行う	手術室

	検査科	**業務の割り振り**：業務を割り振る	検査科
	リハ科	**報告**：スタッフの状況と被害を、本部へ報告する。本部の指示で、業務を割り振る	リハビリ室
	ME	**配置**：赤ゾーンに入る	現地統括本部
	経理（設備）	**設備の確認**：電気、上下水、医療ガス、建物、発電機を確認して、本部へ報告する	防災センター
	地域連携（広報）	**集計**：登院人数と職種を集計して、本部へ報告する	現地統括本部
8:45	災害対策本部	**登院人数の集計**：登院人数を集計する	北館 会議室1
	現地統括本部	**応援の割り振り**：本部から割り振られた、追加の応援を、各ゾーンへ配置する	本館1階 受付会計前ロビー
	新設部門・外来	**チェックリスト**：外来チェックリストを提出する	本館1階 総合案内前ロビー
	腎センター	**チェックリスト**：透析可否と可能人数を、チェックリストで提出する	透析室
	手術室	**チェックリスト**：手術室の可否を、チェックリストで提出して、本部へ報告する	手術室
	病棟	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	各病棟
	薬剤部	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	薬剤部
	検査科	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	検査科
	放射線科	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	放射線科
	栄養科	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	厨房
	リハ科	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	リハビリ室
	ME	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	現地統括本部
	経理（設備）	**燃料・給水**：発電機の運転時間の目安は、地下2階が約12.5時間、本館5階が約23時間、北館が約12時間。使用電力を控えれば延びる	防災センター
	経理（設備）	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	防災センター
	地域連携（広報）	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	現地統括本部
	医局	**チェックリスト**：チェックリストを提出する	医局・当直室
8:50	災害対策本部	**第一報**：被災状況を確認する	北館 会議室1
	現地統括本部	**第一報**：現地統括本部の状況を、本部へ報告する	北館 会議室1
9:00	災害対策本部	**トイレの決定**：節水のためトイレを使用禁止とし、すみやかに仮設トイレを設置する	北館 会議室1
	現地統括本部	**仮設トイレの設置**：現地統括スタッフに、仮設トイレ（テント3つ）の設置を指示する	院内
	現地統括本部	**傷病者の来院**：新設部門リーダーから、傷病者の状況を聞き取る	本館1階 受付会計前ロビー

	新設部門・外来	**傷病者の受け入れ**：総合案内前ロビーにブースを設置し、順にトリアージする	本館1階 総合案内前ロビー
	腎センター	**透析の実施判断**：担架での搬送や、病棟での実施を検討する	透析室
	手術室	**緊急手術**：緊急手術の可否を確認し、特別な手術対応へ進む	手術室
	病棟	**病床調整**：入院患者の安全を確認する	各病棟
	薬剤部	**備蓄の確認**：備蓄医薬品を確認し、本部へ報告する	薬剤部
	検査科	**検査**：黄ゾーンの血液ガス検査を行い、結果を報告する	黄ゾーン・赤ゾーン・北館
	放射線科	**撮影**：ポータブル撮影を行う。記録は紙で行う	ゾーン
	リハ科	**トイレ対応**：各病棟へ、トイレの水が使えないことを伝える	各病棟・トイレ
	ME	**傷病者の受け入れ**：人工呼吸器、モニタ、輸液ポンプを配備し、電源を確保する	赤ゾーン・黄ゾーン
	経理（設備）	**本部の支援**：本部の設営を支援し、物品を調達する	北館2階
	地域連携（広報）	**周知の準備**：院内へ知らせる文書を準備する	広報
9:15	災害対策本部	**余震**：院内放送で伝える。「ただいま、余震がありました。震度5弱です。各部署は安全を確認し、被害の有無を本部へ報告してください。これは訓練です。」	北館 会議室1
	現地統括本部	**余震**：新設部門（各ゾーン）からの被害報告を受け、とりまとめる	本館1階 受付会計前ロビー
	新設部門・外来	**余震**：各ゾーンの安全と、患者の状況を確認する	本館1階 総合案内前ロビー
	腎センター	**余震**：安全を再確認し、透析を続けられるかを検討する。被害の有無を、本部へ報告する	透析室
	手術室	**余震**：器械と設備を確認し、被害の有無を本部へ報告する	手術室
	病棟	**余震**：入院患者の安全を再確認する。被害の有無を、本部へ報告する	各病棟
	薬剤部	**余震**：調剤棚、冷蔵庫、備蓄医薬品を確認し、被害の有無を本部へ報告する	薬剤部
	検査科	**余震**：機器と試薬を確認し、被害の有無を本部へ報告する	検査科
	放射線科	**余震**：機器と撮影室の被害を再確認し、被害の有無を本部へ報告する	放射線科
	栄養科	**余震**：調理場の火気とガスを再確認し、被害の有無を本部へ報告する	厨房

	リハ科	**余震**：リハビリ室の安全を確認し、被害の有無を本部へ報告する	リハビリ室
	ME	**余震**：機器の転倒と、電源の外れを確認して、現地統括本部へ報告する	院内全体
	経理（設備）	**余震**：設備の被害を再確認し、被害の有無を本部へ報告する	設備
	地域連携（広報）	**余震**：安全を確認し、被害の有無を本部へ報告する	広報
	医局	**余震**：医局と当直室の安全を確認し、被害の有無を本部へ報告する	医局・当直室
9:30	災害対策本部	**人手不足への対応**：各ゾーンの状況を、本部へ報告する	北館 会議室1
	現地統括本部	**人手不足の報告**：本部へ、人手不足を報告して、応援を要請する。現地統括ロジの応援も、あわせて要請する	北館 会議室1
	現地統括本部	**赤ゾーンへの応援**：現地統括スタッフ④⑤を、赤ゾーンへ応援に出す	赤ゾーン
	新設部門・外来	**人手不足**：人手の応援を、現地統括本部へ要請する	赤ゾーン
	病棟	**病棟の出来事**：心不全の患者が呼吸苦を訴える。観察して報告する	各病棟
	ME	**人手不足**：機器の整備が済んだら、傷病者の移動補助、記録、物品の運搬を手伝う	赤ゾーン
	医局	**再配置**：医師の再配置を、本部と調整する	現地統括本部
9:45	経理（設備）	**外部からの入電**：電話を受け、本部へつなぐ	防災センター
	地域連携（広報）	**周知**：院内放送と掲示で、状況を知らせる	院内
10:00	新設部門・外来	**第3波**：トリアージを続ける	トリアージセンター
	病棟	**設備の出来事**：医療機器のバッテリーが切れる。予備の電源や機器に替える	各病棟
	地域連携（広報）	**状況報告**：様式に沿って、建物・設備、患者・職員、ライフライン、診療体制、搬送、周辺・交通、DMAT、その他を報告する	本部
10:15	災害対策本部	**受け入れ要請・家族・報道・不足への対応**：病棟、腎センター、MEの空きと機器を確認させ、転院搬送を、受け入れる、断る、人数を減らして受ける、のどれかに決める	北館 会議室1
	現地統括本部	**本部との連携**：不足の状況を、本部へ伝える	本館1階 受付会計前ロビー
	腎センター	**転院搬送の相談**：透析の空きは6床として答える	透析室

	病棟	**追加の出来事**：家族からの問い合わせと、報道機関からの取材に対応する。資機材と薬剤の不足を、本部へ伝える	病棟・本部
	病棟	**転院搬送の相談**：その時点の空床で、ベッドコントロールを行い、受け入れ可能な人数を答える	各病棟
	薬剤部	**薬剤の調達**：県に、ロキソニンテープの搬入を依頼する。本部へ報告する	薬剤部
	ME	**赤ゾーンの逼迫**：現地統括の指示で、黄ゾーンから赤ゾーンへ機器を融通する	赤ゾーン
	ME	**転院搬送の相談**：人工呼吸器の空きは2〜3台として答える	ME
10:30	災害対策本部	**本部会議（定時報告）**：定時報告の内容を、ホワイトボードにまとめる	北館 会議室1
	現地統括本部	**定時報告**：新設部門リーダーから、各ゾーンの状況を集める	本館1階 受付会計前ロビー
	現地統括本部	**本部会議**：本部会議に出席し、定時報告をする	北館 会議室1
	現地統括本部	**非常食の準備**：現地統括スタッフ①②を、栄養科の応援に出す	7階 多目的ホール
	新設部門・外来	**定時報告**：各ゾーンの状況を集めて、現地統括リーダーへ報告する	現地統括本部
	腎センター	**給水**：透析の実施可否を再検討する	透析室
	栄養科	**昼食の準備**：調理と配膳の見通しを、本部へ報告する	7階 多目的ホール
10:30〜11:00	栄養科	**昼食の配膳**：昼食を、看護学生へ配る	7階 多目的ホール
10:30	ME	**定時報告**：稼働台数、バッテリー残量、非常電源の接続数など、機器の状況を報告する	現地統括本部
	経理（設備）	**燃料・給水の供給**：給水口・給油口の口径、タンクの場所、補給の方法を確認して、本部へ報告する	防災センター
	地域連携（広報）	**状況報告②**：内容を更新して報告する	本部
11:00	災害対策本部	**訓練の終了**：訓練の終了を宣言する	北館 会議室1
	地域連携（広報）	**訓練の終了**：院内放送で「訓練を終了します」と伝える	院内

台本｜災害対策本部

配役表

役名	役割	氏名
仮の本部長（当直医師役）	仮本部を設置し、院長へ申し送る	英（統括副院長）
管理当直役	各部署の当直者から被害の報告を受け、本部へ報告する	櫻井
本部長	設置、レベル、終了を宣言する	
本部ロジ①	時系列の記録と、EMIS入力。災害委員が担当	
本部ロジ②	アルカディアの集計と、院内放送。災害委員が担当	
本部員①	参集後に割り当てられた人。本部の指示で、連絡、電話対応、ホワイトボード記入をする	
本部員②	参集後に割り当てられた人。本部の指示で、連絡、電話対応、ホワイトボード記入をする	

台本

7:30　発災　院内

まだ訓練は始まっていません。

管理当直役	各部署の当直者から、被害の報告を受ける

8:00　仮本部の設置　北館 会議室1

7:30～8:00は、当直者が対応しています。当直者が、管理当直へ被害を報告しています。

仮の本部長（当直医師役）	仮本部を設置する
管理当直役	当直者から受けた被害の報告を、仮本部へ報告する
本部ロジ②	院内放送で、「これから、災害訓練を始めます。訓練ですので、患者さんは、ご心配ありません。」と伝える
本部ロジ①	時系列の記録を始める
本部ロジ②	安否確認メールの返信を、アルカディアで集計する

8:00　初動アクションカードの受け取り　北館 会議室1

7:30～8:00は、当直者が対応しています。

各部署の委員	集合のときに、担当する部署の初動アクションカードを、本部へ持ってくる

8:30　本部員の到着	北館 会議室1
本部長	到着し、仮の本部長から本部長を引き継ぐ
仮の本部長（当直医師役）	被害と対応の状況を、本部長へ申し送る
本部員①②	到着し、本部の席に就く

8:35　本部の設置	北館 会議室1
本部長	災害対策本部の設置を宣言する。レベル3を宣言する
本部ロジ②	院内放送で、設置とレベルを伝える
本部ロジ①	設置とレベルを、時系列に記録する
本部	集まったカード（各部署の委員が8:00に持ってきたもの）をもとに、被災状況を整理する
本部員①②	電話の受付と、ホワイトボードへの記入を始める

8:45　登院人数の集計	北館 会議室1
本部ロジ②	登院人数を集計する
本部員①②	各部署のチェックリストを、本部へ渡す
本部	追加の応援を割り振る

8:50　第一報	北館 会議室1
本部	被災状況を確認する
本部ロジ①	EMISへ第一報を入力する。燃料・給水の依頼も入力する

9:00　トイレの決定	北館 会議室1
停電・断水が続いている。	
本部	節水のためトイレを使用禁止とし、すみやかに仮設トイレを設置する
本部ロジ②	院内放送で、トイレの使用禁止を伝える

9:15　余震　　北館 会議室1

余震（震度5弱）が起きる。

本部ロジ②	院内放送で伝える。「ただいま、余震がありました。震度5弱です。各部署は安全を確認し、被害の有無を本部へ報告してください。これは訓練です。」
本部ロジ①	余震の発生を、時系列に記録する
本部員①②	各部署からの被害報告を電話で受け、本部へ伝える
本部	必要があれば、被害のあった部署へ対応を指示する

9:30　人手不足への対応　　北館 会議室1

第2波が来院し、赤ゾーンの人手が足りない。

現地統括リーダー	各ゾーンの状況を、本部へ報告する
本部	人員を再配置する
本部ロジ①	時系列に記録する

10:15　受け入れ要請・家族・報道・不足への対応　　北館 会議室1

和歌山県立医大から、入院患者3名の転院搬送の要請がある（①人工呼吸器の患者、②維持透析が必要な患者、③酸素吸入が必要な患者）。家族対応、報道取材、赤ゾーンの資機材（輸液、酸素ボンベ）の不足が起きる。

本部	病棟、腎センター、MEの空きと機器を確認させ、転院搬送を、受け入れる、断る、人数を減らして受ける、のどれかに決める
本部員①②	家族からの電話と、報道機関からの取材の連絡を受け、本部へ伝える
本部	報道への対応と、赤ゾーンの不足（輸液、酸素ボンベ）への対応を、部署と調整して決める

10:30　本部会議（定時報告）　　北館 会議室1

参加者は、本部長、本部ロジ、現地統括リーダー、新設部門リーダー。

本部員①②	定時報告の内容を、ホワイトボードにまとめる
本部	会議を進め、各ゾーンの状況を確認し、方針を決める
本部ロジ①	時系列に記録する。新設部門の報告をもとに、EMISを更新する

11:00　訓練の終了　　北館 会議室1

本部長	訓練の終了を宣言する
本部ロジ②	院内放送で、訓練の終了を伝える

台本｜現地統括本部

配役表

役名	役割	氏名
現地統括リーダー	現地統括本部をまとめる。新設部門リーダーへ指示し、本部へ報告する情報を集める。災害委員が担当する	
現地統括ロジ①	傷病者一覧の管理、病床・搬送の調整、各ゾーン報告のとりまとめ、院内放送の依頼。災害委員が担当	
現地統括ロジ②	傷病者一覧の管理、病床・搬送の調整、各ゾーン報告のとりまとめ、院内放送の依頼。災害委員が担当	
現地統括スタッフ①	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	
現地統括スタッフ②	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	
現地統括スタッフ③	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	
現地統括スタッフ④	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	
現地統括スタッフ⑤	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	

台本

8:00　設営

本館1階 受付会計前ロビー

現地統括リーダー	現地統括本部を設営する。安否確認メールの返信の集計を、本部ロジ②と確認する
現地統括ロジ①②	設営を手伝う。傷病者一覧（通し番号、ゾーン、帰宅・入院・搬送）の用紙を用意する

8:30　登院

本館1階 受付会計前ロビー

現地統括リーダー	登院登録をして、現地統括本部に着く。新設部門リーダーが着いたことを確認する

8:30　現地統括スタッフの登院

本館1階 受付会計前ロビー

現地統括スタッフ①〜⑤	登院登録をして、現地統括本部で待機する

8:35　新設部門の配置

本館1階 受付会計前ロビー

現地統括リーダー	新設部門リーダーから、配置が済んだか、報告を受ける。電子カルテは使えないため、紙カルテで運用すると伝える
現地統括ロジ①	検査科へ、可能な検査項目を確認する

8:45　応援の割り振り

本館1階 受付会計前ロビー

現地統括リーダー	本部から割り振られた、追加の応援を、各ゾーンへ配置する

8:50　第一報

北館 会議室1

現地統括リーダー	現地統括本部の状況を、本部へ報告する

9:00　仮設トイレの設置

院内

本部が、トイレの使用禁止と仮設トイレの設置を決めた。

現地統括リーダー	現地統括スタッフに、仮設トイレ（テント3つ）の設置を指示する
現地統括スタッフ①〜③	仮設トイレ（テント3つ）を設置する

9:00　傷病者の来院

本館1階 受付会計前ロビー

院外傷病者が来院し始める。第1波。

現地統括リーダー	新設部門リーダーから、傷病者の状況を聞き取る
現地統括ロジ①	各ゾーンから、診療患者数と、帰宅・入院・搬送の判断の報告を受け、傷病者一覧を更新する
現地統括ロジ②	入院が必要な傷病者の病床を、病棟統括と調整する。搬送が必要な傷病者の搬送先を調整する

9:15　余震

本館1階 受付会計前ロビー

院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。

現地統括ロジ①②	新設部門（各ゾーン）からの被害報告を受け、とりまとめる
現地統括リーダー	とりまとめた被害の有無を、本部へ報告する

9:30　人手不足の報告

北館 会議室1

赤ゾーンの人手が足りない。

現地統括リーダー	本部へ、人手不足を報告して、応援を要請する。現地統括ロジの応援も、あわせて要請する

9:30　赤ゾーンへの応援

赤ゾーン

第2波が来院し、赤ゾーンが満床になる。

現地統括リーダー	現地統括スタッフ④⑤を、赤ゾーンへ応援に出す
現地統括スタッフ④⑤	赤ゾーンで、傷病者の移動や物品の運搬を手伝う

10:15　本部との連携

本館1階 受付会計前ロビー

家族対応、報道取材、資機材・薬剤の不足が起きる。

現地統括リーダー	不足の状況を、本部へ伝える

10:30　定時報告

本館1階 受付会計前ロビー

現地統括リーダー	新設部門リーダーから、各ゾーンの状況を集める
現地統括ロジ①	傷病者一覧から、来院数と、帰宅・入院・搬送の数を集計する
現地統括リーダー	各ゾーンの報告をまとめ、本部へ報告する
現地統括ロジ②	院内放送が必要なときは、本部ロジ②へ依頼する

10:30　本部会議

北館 会議室1

現地統括リーダー	本部会議に出席し、定時報告をする

10:30　非常食の準備

7階 多目的ホール

給水の連絡が入る。

現地統括リーダー	現地統括スタッフ①②を、栄養科の応援に出す
現地統括スタッフ①②	非常食の準備と、昼食の配膳を手伝う

台本｜新設部門・外来

配役表

役名	役割	氏名
新設部門リーダー①	新設部門全体の責任者。開始を宣言する。現地統括本部の一員でもある	
トリアージ担当①	2人1組でトリアージを行う	
トリアージ担当②	2人1組でトリアージを行う	
トリアージ事務①	専用IDを作り、各ゾーンへ伝える	
緑ゾーン担当①	緑ゾーンの対応	
黄ゾーン担当①	黄ゾーンの観察と治療	
黄ゾーン担当②	黄ゾーンの観察と治療	
赤ゾーン担当①	赤ゾーンの対応	
黒ゾーン担当①	黒ゾーンの対応	
ゾーンスタッフ①	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	
ゾーンスタッフ②	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	
ゾーンスタッフ③	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	ME担当②
ゾーンスタッフ④	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	ME担当①
ゾーンスタッフ⑤	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	
ゾーンスタッフ⑥	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	

台本

7:30　発災	救急室
棚が倒れ、救急室は使えない。患者はいない。	
新設部門リーダー①	部署LINEで、スタッフの安否確認と参集を呼びかける

8:30　登院	現地統括本部
新設部門リーダー①	現地統括本部へ行き、現地統括リーダーの指示を受ける

8:35　開始準備	本館1階 総合案内前ロビー
ゾーンスタッフ①〜⑥	事前に決めた持ち場に就く
新設部門リーダー①	配置を確認し、ブース配置と搬送経路を決める。現地統括リーダーへ、配置が済んだことを報告する
トリアージ担当①②　黄ゾーン担当①②	ブース用の物品と衛生材料を取りに行く
新設部門リーダー①	トランシーバーを渡し、新設部門の開始を宣言する

8:45　チェックリスト	本館1階 総合案内前ロビー
新設部門リーダー①	外来チェックリストを提出する

9:00　傷病者の受け入れ	本館1階 総合案内前ロビー
第1波が来院する。	
トリアージ担当①②	総合案内前ロビーにブースを設置し、順にトリアージする
トリアージ事務①	トリアージタッグを用意し、通し番号を付ける。各ゾーンへ案内する
緑ゾーン担当①	応急処置を行う。診療患者数と、帰宅の判断を、現地統括本部へ報告する
黄ゾーン担当①②	観察と治療を始める。待機場所を設ける。人数が増えたら再トリアージする。診療患者数と、帰宅・入院・搬送の判断を、現地統括本部へ報告する
赤ゾーン担当①	重症者の治療を行う。診療患者数と、入院・搬送の判断を、現地統括本部へ報告する
黒ゾーン担当①	黒ゾーンの傷病者に対応する。人数を、現地統括本部へ報告する
ゾーンスタッフ①	トリアージ担当を手伝い、傷病者の誘導と記録を行う
ゾーンスタッフ②	緑ゾーンで、担当の指示で動く
ゾーンスタッフ③	黄ゾーンで、担当の指示で動く
ゾーンスタッフ④⑤	赤ゾーンで、担当の指示で動く
ゾーンスタッフ⑥	黒ゾーンで、担当の指示で動く
新設部門リーダー①	各ゾーンの状況を見て、必要なことを現地統括リーダーへ伝える

9:15　余震　　本館1階 総合案内前ロビー

院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。

新設部門リーダー①	各ゾーンの安全と、患者の状況を確認する
新設部門リーダー①	被害の有無を、現地統括本部へ報告する

9:30　人手不足　　赤ゾーン

第2波が来院し、赤ゾーンが満床になる。

新設部門リーダー①	人手の応援を、現地統括本部へ要請する

10:00　第3波　　トリアージセンター

緑・黄が中心。

トリアージ担当①②	トリアージを続ける

10:30　定時報告　　現地統括本部

新設部門リーダー①	各ゾーンの状況を集めて、現地統括リーダーへ報告する

台本｜腎センター

配役表

役名	役割	氏名
腎センター責任者①	透析の可否を判断し、本部へ報告する	
透析スタッフ①	安全確認と機器・資材の確認	
透析スタッフ②	安全確認と機器・資材の確認	
腎センターの委員	初動アクションカードを、集合のときに本部へ持っていく	武田

台本

7:30　発災　自宅

透析スタッフ①②	安否を入力する。出勤できる人は出勤する

8:00　開始　透析室

スタッフは7:45から順に出勤する。外来患者が来院し始める。

腎センター責任者①	8:30の透析開始の可否を判断し、本部へ報告する

8:00　初動アクションカード　本部

7:30〜8:00は、当直者が対応しています。早出で勤務中。

腎センターの委員	記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく

8:35　被害確認　透析室

透析スタッフ①②	機器の作動と破損、透析資材、発電機、貯水量を確認する
透析スタッフ①②	外来透析患者の安否と来院手段を確認する

8:45　チェックリスト　透析室

腎センター責任者①	透析可否と可能人数を、チェックリストで提出する

9:00　透析の実施判断　透析室

停電のため、エレベーターが使えない。入院患者を、透析室へ搬送できない。

腎センター責任者①	担架での搬送や、病棟での実施を検討する
腎センター責任者①	実施する場合は、ベッドと透析条件を調整する
腎センター責任者①	実施できない場合は、患者への連絡と振替施設を調整する

9:15　余震　　透析室

腎センター責任者①	安全を再確認し、透析を続けられるかを検討する。被害の有無を、本部へ報告する

10:15　転院搬送の相談　　透析室

本部から、維持透析が必要な患者の受け入れの相談が入る。

腎センター責任者①	透析の空きは6床として答える

10:30　給水　　透析室

給水の連絡が入る。

腎センター責任者①	透析の実施可否を再検討する

台本｜手術室

配役表

役名	役割	氏名
手術室責任者①	被害をまとめ、本部へ報告する	
手術室看護師①	器械と衛生材料の確認	
手術室看護師②	器械と衛生材料の確認	
中材①	洗浄・滅菌室の確認	
中材②	洗浄・滅菌室の確認	

台本

7:30　発災　手術室

勤務者も患者もいない。前日の手術器械の洗浄が残っている。

手術室責任者①	グループLINEで、スタッフの安否と出勤の可否を確認する

8:30　登院　手術室

中材は8:00に出勤する。

手術室看護師①②	チェックリストに沿って、手術室内を確認する
手術室責任者①	手術に対応できるかを判断する

8:35　被害の報告　手術室

手術室看護師①②	麻酔器は使える。電気メスなどは、電源があれば使える。手洗い場は使えない。記録は紙で行う
中材①②	ウォッシャーとオートクレーブは使えず、新しい滅菌はできない。配盤室は棚が倒れ、器械が散乱している

8:45　チェックリスト　手術室

手術室責任者①	手術室の可否を、チェックリストで提出して、本部へ報告する

9:00　緊急手術　手術室

予定手術はない。

手術室責任者①	緊急手術の可否を確認し、特別な手術対応へ進む

9:15　余震　手術室

院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。

手術室責任者①	器械と設備を確認し、被害の有無を本部へ報告する

台本｜病棟

配役表

役名	役割	氏名
病棟統括①	全病棟のとりまとめ	
3階東 看護師①	脳神経外科・糖尿病代謝内科	
3階西 看護師②	循環器・血管外科	
4階東 看護師③	消化器内科・外科	
4階西 看護師④	整形外科	
6階 看護師⑤	回復期リハ	
5階（閉棟中）	アクションカードの動きのみ	

台本

7:30　発災　全病棟

夜勤者が対応する。

各病棟の看護師	患者、設備、ナースコール、薬剤の安全確認をして、問題なしと報告する

8:00　初動アクションカード　各病棟

7:30〜8:00は、当直者が対応しています。夜勤者が対応している。

病棟の委員	記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく

8:45　チェックリスト　各病棟

病棟統括①	チェックリストを提出する

9:00　病床調整　各病棟

病棟統括①	入院患者の安全を確認する
病棟統括①	現地統括本部から、入院の相談が入る。各病棟の空床と看護体制を確認して答える

9:15　余震　各病棟

各病棟の看護師	入院患者の安全を再確認する。被害の有無を、本部へ報告する

9:30　病棟の出来事	各病棟
3階西 看護師②	心不全の患者が呼吸苦を訴える。観察して報告する
3階東 看護師①	認知症の患者が病室を離れる。探して安全を確保する
4階西 看護師④	骨折術後の患者が転倒する。観察して医師へ報告する
6階 看護師⑤	認知症の患者の所在が分からなくなる。探して本部へ報告する

10:00　設備の出来事	各病棟
各病棟の看護師	医療機器のバッテリーが切れる。予備の電源や機器に替える

10:15　追加の出来事	病棟・本部
病棟統括①	家族からの問い合わせと、報道機関からの取材に対応する。資機材と薬剤の不足を、本部へ伝える

10:15　転院搬送の相談	各病棟
本部から、転院搬送3名の受け入れの相談が入る。	
病棟統括①	その時点の空床で、ベッドコントロールを行い、受け入れ可能な人数を答える

台本｜薬剤部

配役表

役名	役割	氏名
薬剤部責任者①	被害と備蓄の状況を、本部へ報告する	
当直薬剤師①	7:30の当直者（委員が演じる）	小上
薬剤師②	紙の処方への対応	

台本

7:30　発災　薬剤部

調剤棚・分包機・冷蔵庫は使える。赤いコンセントも使える。

当直薬剤師①	初動アクションカードで状況を確認し、管理当直へ報告する

8:00　初動アクションカード　薬剤部

7:30〜8:00は、当直者が対応しています。

当直薬剤師①	記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく

8:30　登院　薬剤部

薬剤部責任者①	部内の連絡網で安否を確認し、本部へ報告する

8:45　チェックリスト　薬剤部

薬剤部責任者①	チェックリストを提出する
薬剤師②	新設部門と病棟の処方に、紙で対応する

9:00　備蓄の確認　薬剤部

ロキソニンテープだけ、残りが少ない。

薬剤部責任者①	備蓄医薬品を確認し、本部へ報告する

9:15　余震　薬剤部

院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。

薬剤部責任者①	調剤棚、冷蔵庫、備蓄医薬品を確認し、被害の有無を本部へ報告する

10:15　薬剤の調達　薬剤部

卸は動いていない。

薬剤部責任者①	県に、ロキソニンテープの搬入を依頼する。本部へ報告する

台本｜検査科

配役表

役名	役割	氏名
検査科所属長①	人員の招集と、業務の割り振り	
当直検査技師①	7:30の当直者（委員が演じる）	原見
検査技師②	黄ゾーンの血液ガス検査	
検査技師③	赤ゾーンの血液ガス検査と、緊急輸血	
生理検査技師④	心電図検査	
応援の検査技師⑤	割り振られた部門で応援	
応援の検査技師⑥	割り振られた部門で応援	

台本

7:30　発災　検査科

当直検査技師①	連絡網で所属長へ連絡する
検査科所属長①	人員を招集し、病院へ向かう

8:00　初動アクションカード　検査科

7:30〜8:00は、当直者が対応しています。

当直検査技師①	記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく

8:35　業務の割り振り　検査科

検査科所属長①	業務を割り振る
応援の検査技師⑤⑥	割り振られた部門へ向かう
検査技師②③　生理検査技師④	新設部門の業務を行う。試薬の避難、毒物・劇物の施錠、試薬の卸への連絡も行う

8:45　チェックリスト　検査科

検査科所属長①	チェックリストを提出する

9:00　検査　黄ゾーン・赤ゾーン・北館

検査技師②	黄ゾーンの血液ガス検査を行い、結果を報告する
検査技師③	赤ゾーンの血液ガス検査を行う。血液型が不明の患者に、O型の緊急輸血を行う
生理検査技師④	北館から機器を運び、心電図検査を行う

9:15　余震	検査科
院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。	
検査科所属長①	機器と試薬を確認し、被害の有無を本部へ報告する

台本｜放射線科

配役表

役名	役割	氏名
放射線科責任者①	被害確認と、本部への報告	
当直放射線技師①	7:30の当直者（委員が演じる）	引網
放射線技師②	ポータブル撮影とロジ活動	
放射線技師③	ポータブル撮影とロジ活動	

台本

7:30　発災　　放射線科

使える機器はポータブル撮影のみ。一般撮影、CT、MRI、アンギオ、X線TV、骨密度、部門システムは使えない。

当直放射線技師①	安全確認と被害確認をして、管理当直へ報告する
当直放射線技師①	グループLINEで、スタッフの安否を確認する

8:00　初動アクションカード　　放射線科

7:30〜8:00は、当直者が対応しています。

当直放射線技師①	記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく

8:30　登院　　現地統括本部

放射線科責任者①	登院登録をする

8:45　チェックリスト　　放射線科

放射線科責任者①	チェックリストを提出する

9:00　撮影　　ゾーン

放射線技師②③	ポータブル撮影を行う。記録は紙で行う
放射線技師②③	ゾーンのロジ活動を手伝う

9:15　余震　　放射線科

放射線科責任者①	機器と撮影室の被害を再確認し、被害の有無を本部へ報告する

台本｜栄養科

配役表

役名	役割	氏名
厨房マネージャー①	厨房の判断と、配膳の指揮	
厨房調理師①	早出で勤務中の厨房スタッフ	
厨房調理師②	早出で勤務中の厨房スタッフ	
提供先（看護学生）	昼食を受け取る看護学生	
栄養科の委員	初動アクションカードを、集合のときに本部へ持っていく	谷山

台本

7:30　発災　厨房

棚が倒れ、厨房は使えない。朝食は、すべて配膳済み。

厨房調理師①②	安全を確保し、火を止める。被害を確認して、管理当直へ報告する
厨房マネージャー①	部署の連絡ツールで、スタッフの安否と参集を確認する

8:00　初動アクションカード　本部

7:30〜8:00は、当直者が対応しています。早出の厨房スタッフが勤務中。

栄養科の委員	記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく

8:30　登院　厨房

厨房マネージャー①	厨房の状況と調理の可否を、本部へ報告する
厨房マネージャー①	冷蔵庫の食品を移す。昼食を非常食にするかを判断する

8:45　チェックリスト　厨房

厨房マネージャー①	チェックリストを提出する

9:15　余震　厨房

厨房マネージャー①	調理場の火気とガスを再確認し、被害の有無を本部へ報告する

10:30　昼食の準備

7階 多目的ホール

給水の連絡が入る。

厨房マネージャー①	調理と配膳の見通しを、本部へ報告する
厨房マネージャー①　厨房調理師①②	7階多目的ホールで、非常食（1日目の昼）を準備する。使い捨て食器を使う
現地統括スタッフ①②	現地統括本部から応援に来て、非常食の準備を手伝う
厨房マネージャー①	食数、食種、アレルギーを確認して、簡易食札を書く

10:30〜11:00　昼食の配膳

7階 多目的ホール

厨房調理師①②　現地統括スタッフ①②	昼食を、看護学生へ配る
厨房マネージャー①	残数を記録し、トレーを回収する

台本｜リハ科

配役表

役名	役割	氏名
リハ科責任者①	被害を報告し、業務を割り振る	
リハ科スタッフ①	他部門の応援とトイレ対応	
リハ科スタッフ②	他部門の応援とトイレ対応	
リハ科スタッフ③	他部門の応援とトイレ対応	

台本

7:30　発災　— 自宅

リハ科スタッフ①②③	安全を確保し、グループLINEで安否を確認する。登院できるかを確認する

8:30　登院　— リハビリ室

リハ科責任者①	リハビリ室の被害を確認する

8:35　報告　— リハビリ室

リハ科責任者①	スタッフの状況と被害を、本部へ報告する。本部の指示で、業務を割り振る

8:45　チェックリスト　— リハビリ室

リハ科責任者①	チェックリストを提出する

9:00　トイレ対応　— 各病棟・トイレ

リハビリは中止し、他部門の応援とトイレ対応に回る。

リハ科スタッフ①②③	各病棟へ、トイレの水が使えないことを伝える
リハ科スタッフ①②③	災害用トイレの凝固剤とごみ袋を置き、使い方を貼る
リハ科スタッフ①②③	本部の指示で、仮設トイレの設置を手伝う

9:15　余震　— リハビリ室

院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。

リハ科責任者①	リハビリ室の安全を確認し、被害の有無を本部へ報告する

台本｜ME

配役表

役名	役割	氏名
ME担当①	赤ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	
ME担当②	黄ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	

台本

8:30　登院　— 現地統括本部

ME担当①②	登院登録をする

8:35　配置　— 現地統括本部

ME担当①	赤ゾーンに入る
ME担当②	黄ゾーンに入る

8:45　チェックリスト　— 現地統括本部

ME担当①	チェックリストを提出する

9:00　傷病者の受け入れ　— 赤ゾーン・黄ゾーン

ME担当①②	人工呼吸器、モニタ、輸液ポンプを配備し、電源を確保する

9:15　余震　— 院内全体

ME担当①②	機器の転倒と、電源の外れを確認して、現地統括本部へ報告する

9:30　人手不足　— 赤ゾーン

ME担当①②	機器の整備が済んだら、傷病者の移動補助、記録、物品の運搬を手伝う

10:15　赤ゾーンの逼迫　— 赤ゾーン

ME担当①②	現地統括の指示で、黄ゾーンから赤ゾーンへ機器を融通する

10:15　転院搬送の相談　— ME

本部から、人工呼吸器を使う患者の受け入れの相談が入る。

ME担当①②	人工呼吸器の空きは2〜3台として答える

10:30　定時報告　— 現地統括本部

ME担当①②	稼働台数、バッテリー残量、非常電源の接続数など、機器の状況を報告する

台本｜経理（設備）

配役表

役名	役割	氏名
施設担当①	設備の確認と、燃料・給水の手配	
防災センター担当①	ワイドスターの電話受け	
事務②	本部設営の支援と、物品の調達	

台本

8:30　登院　　現地統括本部

施設担当①　事務②　登院登録をする

8:35　設備の確認　　防災センター

施設担当①　電気、上下水、医療ガス、建物、発電機を確認して、本部へ報告する

8:45　燃料・給水　　防災センター

復電しない。

施設担当①　発電機の運転時間の目安は、地下2階が約12.5時間、本館5階が約23時間、北館が約12時間。使用電力を控えれば延びる

施設担当①　酒直へ給油を、自治体へ給水車を依頼する。依頼した内容は、本部へ伝え、EMISにも入力してもらう。燃料の残りを確認し、高架水槽へ揚水する。院内に節水・節電を依頼する

8:45　チェックリスト　　防災センター

施設担当①　チェックリストを提出する

9:00　本部の支援　　北館2階

事務②　本部の設営を支援し、物品を調達する

9:15　余震　　設備

施設担当①　設備の被害を再確認し、被害の有無を本部へ報告する

9:45　外部からの入電　　防災センター

ワイドスターに、自治体（県）から入電がある。「院内の被害状況と、いま受け入れられる傷病者数を教えてください」

防災センター担当①　電話を受け、本部へつなぐ

10:30　燃料・給水の供給　　防災センター

供給は明日の見込み。自衛隊から、口径や場所などの問い合わせの連絡が入る。

施設担当①	給水口・給油口の口径、タンクの場所、補給の方法を確認して、本部へ報告する

台本｜地域連携（広報）

配役表

役名	役割	氏名
登院登録担当①	登院者管理表への記名と集計	
広報担当②	院内放送の文案と、周知文書の準備	

台本

8:00　準備　現地統括本部

登院登録担当①	登院者管理表を準備する

8:30　登院　現地統括本部

登院登録担当①	参集者に、登院者管理表へ記名してもらう

8:35　集計　現地統括本部

登院登録担当①	登院人数と職種を集計して、本部へ報告する
広報担当②	院内放送の文案を、本部ロジ②へ渡す

8:45　チェックリスト　現地統括本部

広報担当②	チェックリストを提出する

9:00　周知の準備　広報

広報担当②	院内へ知らせる文書を準備する

9:15　余震　広報

院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。

広報担当②	安全を確認し、被害の有無を本部へ報告する

9:45　周知　院内

広報担当②	院内放送と掲示で、状況を知らせる

10:00　状況報告　本部

広報担当②	様式に沿って、建物・設備、患者・職員、ライフライン、診療体制、搬送、周辺・交通、DMAT、その他を報告する

10:30　状況報告②	本部
広報担当②	内容を更新して報告する

11:00　訓練の終了	院内
広報担当②	院内放送で「訓練を終了します」と伝える

台本｜医局

配役表

役名	役割	氏名
当直医役	7:30の当直医（8時集合の災害委員が演じる）	英（統括副院長）
医局代表①	医師の配置を、本部と調整する	
ゾーンリーダー（医師）①	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）②	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）③	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）④	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	
ゾーンリーダー（医師）⑤	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	

台本

7:30　発災

医局・当直室

当直医役	初動アクションカードで状況を確認し、管理当直へ報告する

8:00　初動アクションカード

医局・当直室

7:30〜8:00は、当直者が対応しています。

当直医役	記入した初動アクションカードを、集合のときに、本部へ持っていく

8:30　登院

現地統括本部

医局代表①	登院登録をする

8:45　チェックリスト

医局・当直室

医局代表①	チェックリストを提出する

9:15　余震

医局・当直室

院内放送で、余震（震度5弱）が伝えられる。

医局代表①	医局と当直室の安全を確認し、被害の有無を本部へ報告する

9:30　再配置

現地統括本部

医局代表①	医師の再配置を、本部と調整する

全体配役表

区分	部署	役名	主な動き	時刻	氏名
進行		**進行役**	訓練全体の進行と時間管理。終了を宣言する	7:30	
災害対策本部	災害対策本部	**仮の本部長（当直医師役）**	仮本部を設置し、院長へ申し送る	8:00	英（統括副院長）
災害対策本部	災害対策本部	**管理当直役**	各部署の当直者から被害の報告を受け、本部へ報告する	7:30	櫻井
災害対策本部	災害対策本部	**本部長**	設置、レベル、終了を宣言する	8:30	
災害対策本部	災害対策本部	**本部ロジ①**	時系列の記録と、EMIS入力。災害委員が担当	8:00	
災害対策本部	災害対策本部	**本部ロジ②**	アルカディアの集計と、院内放送。災害委員が担当	8:00	
災害対策本部	災害対策本部	**本部員①**	参集後に割り当てられた人。本部の指示で、連絡、電話対応、ホワイトボード記入をする	8:30	
災害対策本部	災害対策本部	**本部員②**	参集後に割り当てられた人。本部の指示で、連絡、電話対応、ホワイトボード記入をする	8:30	
現地統括本部	現地統括本部	**現地統括リーダー**	現地統括本部をまとめる。新設部門リーダーへ指示し、本部へ報告する情報を集める。災害委員が担当する	8:00	
現地統括本部	現地統括本部	**現地統括ロジ①**	傷病者一覧の管理、病床・搬送の調整、各ゾーン報告のとりまとめ、院内放送の依頼。災害委員が担当	8:00	
現地統括本部	現地統括本部	**現地統括ロジ②**	傷病者一覧の管理、病床・搬送の調整、各ゾーン報告のとりまとめ、院内放送の依頼。災害委員が担当	8:00	
現地統括本部	現地統括本部	**現地統括スタッフ①**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	8:30	
現地統括本部	現地統括本部	**現地統括スタッフ②**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	8:30	

現地統括本部	現地統括本部	**現地統括スタッフ③**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	8:30	
現地統括本部	現地統括本部	**現地統括スタッフ④**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	8:30	
現地統括本部	現地統括本部	**現地統括スタッフ⑤**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてある。現地統括リーダーの指示で動く（トイレ設置、赤ゾーンの応援、非常食の準備など）	8:30	
各部署	新設部門・外来	**新設部門リーダー①**	新設部門全体の責任者。開始を宣言する。現地統括本部の一員でもある	7:30	
各部署	新設部門・外来	**トリアージ担当①**	2人1組でトリアージを行う	8:35	
各部署	新設部門・外来	**トリアージ担当②**	2人1組でトリアージを行う	8:35	
各部署	新設部門・外来	**トリアージ事務①**	専用IDを作り、各ゾーンへ伝える	9:00	
各部署	新設部門・外来	**緑ゾーン担当①**	緑ゾーンの対応	9:00	
各部署	新設部門・外来	**黄ゾーン担当①**	黄ゾーンの観察と治療	8:35	
各部署	新設部門・外来	**黄ゾーン担当②**	黄ゾーンの観察と治療	8:35	
各部署	新設部門・外来	**赤ゾーン担当①**	赤ゾーンの対応	9:00	
各部署	新設部門・外来	**黒ゾーン担当①**	黒ゾーンの対応	9:00	
各部署	新設部門・外来	**ゾーンスタッフ①**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	8:35	
各部署	新設部門・外来	**ゾーンスタッフ②**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	8:35	
各部署	新設部門・外来	**ゾーンスタッフ③**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	8:35	ME担当②
各部署	新設部門・外来	**ゾーンスタッフ④**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	8:35	ME担当①

各部署	新設部門・外来	**ゾーンスタッフ⑤**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	8:35	
各部署	新設部門・外来	**ゾーンスタッフ⑥**	参集後に割り当てられた人。事前に決めてあるゾーンで、ゾーンのリーダー（医師）の指示で動く（①トリアージ ②緑 ③黄 ④⑤赤 ⑥黒）	8:35	
各部署	腎センター	**腎センター責任者①**	透析の可否を判断し、本部へ報告する	8:00	
各部署	腎センター	**透析スタッフ①**	安全確認と機器・資材の確認	7:30	
各部署	腎センター	**透析スタッフ②**	安全確認と機器・資材の確認	7:30	
各部署	腎センター	**腎センターの委員**	初動アクションカードを、集合のときに本部へ持っていく	8:00	武田
各部署	手術室	**手術室責任者①**	被害をまとめ、本部へ報告する	7:30	
各部署	手術室	**手術室看護師①**	器械と衛生材料の確認	8:30	
各部署	手術室	**手術室看護師②**	器械と衛生材料の確認	8:30	
各部署	手術室	**中材①**	洗浄・滅菌室の確認	8:35	
各部署	手術室	**中材②**	洗浄・滅菌室の確認	8:35	
各部署	病棟	**病棟統括①**	全病棟のとりまとめ	8:45	
各部署	病棟	**3階東 看護師①**	脳神経外科・糖尿病代謝内科	9:30	
各部署	病棟	**3階西 看護師②**	循環器・血管外科	9:30	
各部署	病棟	**4階東 看護師③**	消化器内科・外科	7:30	
各部署	病棟	**4階西 看護師④**	整形外科	9:30	
各部署	病棟	**6階 看護師⑤**	回復期リハ	9:30	
各部署	病棟	**5階（閉棟中）**	アクションカードの動きのみ	7:30	
各部署	薬剤部	**薬剤部責任者①**	被害と備蓄の状況を、本部へ報告する	8:30	

各部署	薬剤部	**当直薬剤師①**	7:30の当直者（委員が演じる）	7:30	小上
各部署	薬剤部	**薬剤師②**	紙の処方への対応	7:30	
各部署	検査科	**検査科所属長①**	人員の招集と、業務の割り振り	7:30	
各部署	検査科	**当直検査技師①**	7:30の当直者（委員が演じる）	7:30	原見
各部署	検査科	**検査技師②**	黄ゾーンの血液ガス検査	7:30	
各部署	検査科	**検査技師③**	赤ゾーンの血液ガス検査と、緊急輸血	7:30	
各部署	検査科	**生理検査技師④**	心電図検査	8:35	
各部署	検査科	**応援の検査技師⑤**	割り振られた部門で応援	8:35	
各部署	検査科	**応援の検査技師⑥**	割り振られた部門で応援	8:35	
各部署	放射線科	**放射線科責任者①**	被害確認と、本部への報告	8:30	
各部署	放射線科	**当直放射線技師①**	7:30の当直者（委員が演じる）	7:30	引網
各部署	放射線科	**放射線技師②**	ポータブル撮影とロジ活動	7:30	
各部署	放射線科	**放射線技師③**	ポータブル撮影とロジ活動	7:30	
各部署	栄養科	**厨房マネージャー①**	厨房の判断と、配膳の指揮	7:30	
各部署	栄養科	**厨房調理師①**	早出で勤務中の厨房スタッフ	7:30	
各部署	栄養科	**厨房調理師②**	早出で勤務中の厨房スタッフ	7:30	
各部署	栄養科	**提供先（看護学生）**	昼食を受け取る看護学生	7:30	
各部署	栄養科	**栄養科の委員**	初動アクションカードを、集合のときに本部へ持っていく	8:00	谷山
各部署	リハ科	**リハ科責任者①**	被害を報告し、業務を割り振る	8:30	
各部署	リハ科	**リハ科スタッフ①**	他部門の応援とトイレ対応	7:30	

各部署	リハ科	**リハ科スタッフ②**	他部門の応援とトイレ対応	7:30	
各部署	リハ科	**リハ科スタッフ③**	他部門の応援とトイレ対応	7:30	
各部署	ME	**ME担当①**	赤ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	8:30	
各部署	ME	**ME担当②**	黄ゾーンの機器の配備と、電源・バッテリーの管理	8:30	
各部署	経理（設備）	**施設担当①**	設備の確認と、燃料・給水の手配	8:30	
各部署	経理（設備）	**防災センター担当①**	ワイドスターの電話受け	9:45	
各部署	経理（設備）	**事務②**	本部設営の支援と、物品の調達	8:30	
各部署	地域連携（広報）	**登院登録担当①**	登院者管理表への記名と集計	8:00	
各部署	地域連携（広報）	**広報担当②**	院内放送の文案と、周知文書の準備	8:35	
各部署	医局	**当直医役**	7:30の当直医（8時集合の災害委員が演じる）	7:30	英（統括副院長）
各部署	医局	**医局代表①**	医師の配置を、本部と調整する	8:30	
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）①**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35	
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）②**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35	
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）③**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35	
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）④**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35	
各部署	医局	**ゾーンリーダー（医師）⑤**	トリアージセンターと、緑・黄・赤・黒ゾーンのリーダー	8:35	
特別な役	看護学生	**傷病者役（約15名）**	第1〜3波で来院し、傷病者カードを演じる	9:00	

特別な役	看護学生	**外部役（約5名で兼任）**	県（ワイドスター）・保健所（県立医大の転院搬送）・酒直・自衛隊・DMAT・家族・報道の入電や要請を演じる	9:45

名簿

参加者の人数の把握に使います。氏名の入力は全体配役表で行います。

部署	役の数	氏名あり	決まっている氏名
進行	1	0	
災害対策本部	7	2	仮の本部長（当直医師役）：英（統括副院長）、管理当直役：櫻井
現地統括本部	8	0	
新設部門・外来	15	2	ゾーンスタッフ③：ME担当②、ゾーンスタッフ④：ME担当①
腎センター	4	1	腎センターの委員：武田
手術室	5	0	
病棟	7	0	
薬剤部	3	1	当直薬剤師①：小上
検査科	7	1	当直検査技師①：原見
放射線科	4	1	当直放射線技師①：引網
栄養科	5	1	栄養科の委員：谷山
リハ科	4	0	
ME	2	0	
経理（設備）	3	0	
地域連携（広報）	2	0	
医局	7	1	当直医役：英（統括副院長）
看護学生	2	0	
合計	**86**	**10**	